Planificación y evaluación de la promoción de la salud y la acción local en salud

CURSO | Programa | 30 horas: 15 presenciales + 15 no presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Del conocimiento del territorio a un plan que pueda evaluarse: priorizar, diseñar actuaciones, medir y devolver resultados.

Problema de partida

En la acción local en salud es frecuente que el plan sea una lista de actividades y que la evaluación se reduzca a contar asistentes. El problema no suele aparecer al evaluar, sino antes: cuando los objetivos se formulan como tareas, cuando las actuaciones no tienen responsable identificable o cuando nadie registró el valor de partida de los indicadores. Este curso sostiene una idea de trabajo: la posibilidad de evaluar un plan se decide en el momento de planificarlo. Por eso trata la planificación y la evaluación como un único recorrido.

Destinatarios

Enfermería especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria (residentes y especialistas), trabajo social sanitario y municipal, medicina familiar y comunitaria y medicina preventiva y salud pública. Abierto a otros perfiles de atención primaria, servicios sociales, salud pública y técnicos municipales que participen en grupos motores o en actividades de promoción de la salud. No se exige formación previa en planificación.

Resultados de aprendizaje

- Situar una intervención dentro del ciclo de planificación local (diagnóstico, perfil, planificación, decisión política, ejecución y evaluación) y reconocer cuándo se mezclan etapas.
- Distinguir en un diagnóstico hechos, inferencias, hipótesis y decisiones, y tratar activos y conocimiento ciudadano como evidencia.
- Aplicar criterios explícitos de priorización y documentar una decisión deliberativa, incluidas las necesidades que no se priorizan.
- Formular objetivos verificables y diferenciar objetivo, actuación, actividad, entrega y consolidación.
- Construir fichas de indicador con definición operativa, fuente, tiempo cero, meta y responsable de medición.
- Diseñar un plan de evaluación proporcionado (proceso, resultados y, cuando sea posible, impacto) y prever la devolución de resultados a la comunidad.
- Diferenciar las actuaciones propias del municipio de las que corresponden al sistema sanitario en el marco de la Estrategia de Salud Comunitaria de Andalucía (ESCA).

Estructura

S1 · 5 h
Contenido: Del conocimiento del territorio a las prioridades · Formato: Presencial

Planificación y evaluación de la promoción de la salud y la acción local en salud

CURSO | Programa | 30 horas: 15 presenciales + 15 no presenciales

T1 · 5 h
Contenido: Documento de priorización deliberativa · Formato: No presencial

S2 · 5 h
Contenido: Del objetivo a la actuación: un plan que pueda evaluarse · Formato: Presencial

T2 · 5 h
Contenido: Plan de acción de una prioridad y fichas de indicador · Formato: No presencial

S3 · 5 h
Contenido: Evaluar la promoción de la salud y la acción local · Formato: Presencial

T3 · 5 h
Contenido: Marco de evaluación y plan de devolución · Formato: No presencial

Metodología

Aprendizaje basado en un caso progresivo: Sierranueva, municipio ficticio con datos inventados para la docencia. Cada sesión parte del producto entregado en el trabajo anterior, de modo que al final el alumnado dispone de una cadena completa: prioridad, objetivos, actuaciones, indicadores y marco de evaluación. Se admite trabajar sobre el territorio propio si se dispone de información pública o autorizada; en ese caso no se incorporan datos personales ni información clínica individual. Trabajo en grupos interprofesionales de 4 a 5 personas, procurando que en cada grupo haya perfiles de enfermería, trabajo social y medicina.

Aportación de cada perfil profesional

Enfermería Familiar y Comunitaria
Aportación habitual al ciclo: Conocimiento de familias y cuidados, educación para la salud grupal, recomendación de activos, seguimiento de actuaciones en el centro de salud · Riesgo que conviene vigilar: Reducir la acción local a actividades grupales del centro de salud

Trabajo social
Aportación habitual al ciclo: Lectura de determinantes sociales, redes y recursos del territorio, coordinación intersectorial y con servicios sociales comunitarios · Riesgo que conviene vigilar: Que el diagnóstico social quede como anexo y no informe la priorización

Medicina
Aportación habitual al ciclo: Lectura epidemiológica, consulta orientada a la comunidad, identificación de patrones en la práctica clínica, comparación de indicadores · Riesgo que conviene vigilar: Priorizar solo lo que se mide bien y desatender necesidades sentidas

Planificación y evaluación de la promoción de la salud y la acción local en salud

CURSO | Programa | 30 horas: 15 presenciales + 15 no presenciales

Evaluación del alumnado (propuesta)

- Asistencia a las tres sesiones presenciales, con el requisito que fije la entidad acreditadora.
- Tres trabajos no presenciales, cada uno con rúbrica de 10 puntos. Propuesta de apto: 5 o más puntos en cada trabajo.
- Cuestionario inicial y final no calificable, para conocer el punto de partida y el cambio percibido.
- Encuesta de satisfacción y propuestas de mejora al cierre de S3.

Herramientas propias que se utilizan

Lista de comprobación de planificación de EpS grupal (B. Hermoso, J. Serrano; 44 ítems)
S2 y T2: revisar una actuación grupal antes de ejecutarla

Lista de comprobación de evaluación de EpS grupal (B. Hermoso, J. Serrano; 33 ítems)
S3 y T3: revisar el sistema de evaluación de una actuación

Modelo metodológico de COMPÁS NG (ciclo, gramática del plan, fichas de actuación e indicador)
Marco conceptual de las tres sesiones

RAPS · Registro de Actuaciones de Promoción de la Salud (REDCap, DS Granada-Metropolitano)
S3: qué puede y qué no puede decir un registro de actividad

Plantillas CSV del curso (priorización, plan de acción, ficha de indicador, plan de evaluación)
Trabajos no presenciales

Estado de esta propuesta

Propuesta docente. Fechas, sede, acreditación y profesorado pendientes de concretar y validar por la entidad organizadora. El caso Sierranueva es ficticio: sus cifras no describen ningún municipio real y no deben citarse fuera del curso.

El caso Sierranueva es ficticio: sus datos son inventados para la docencia. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.